

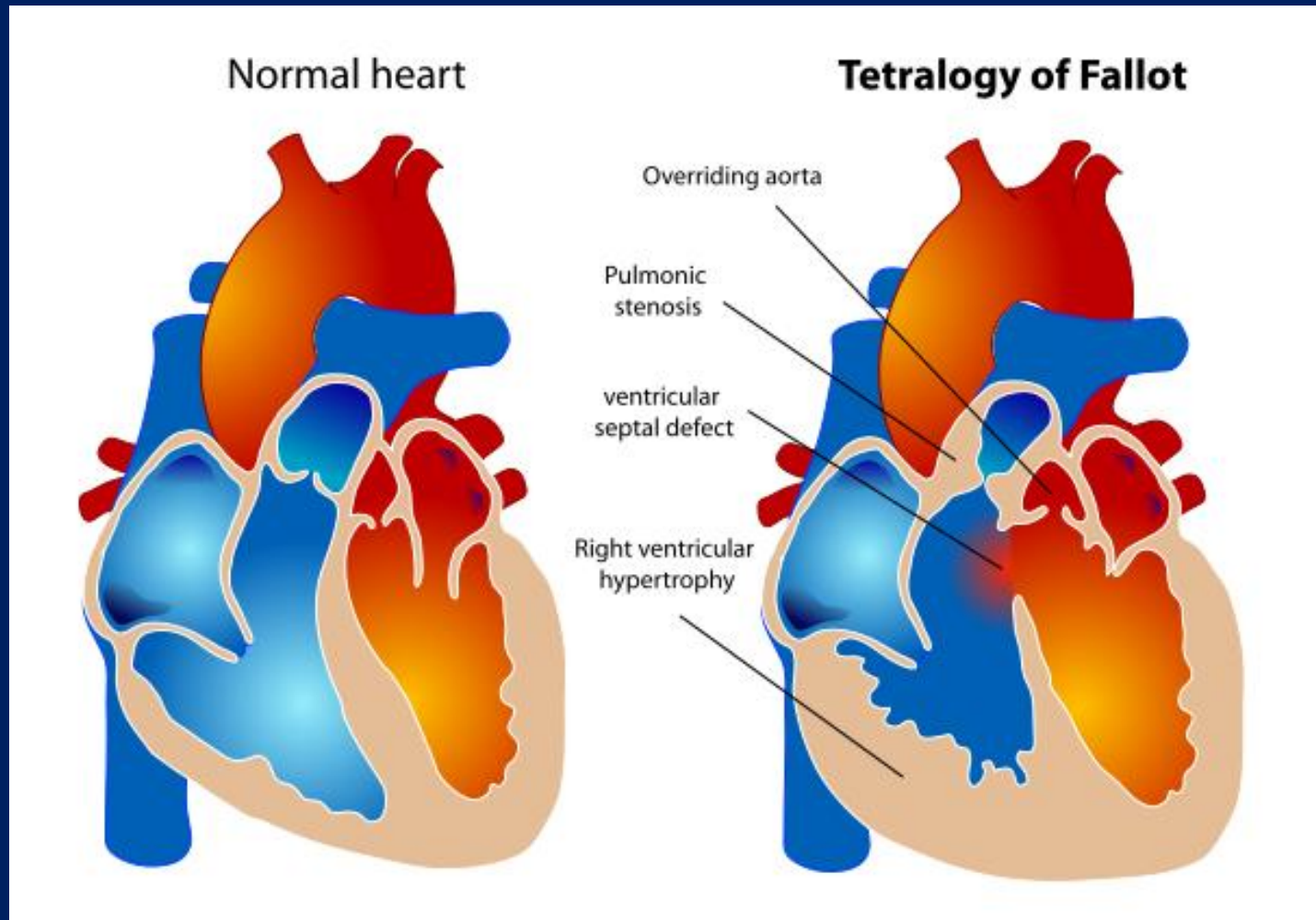
TETRALOGIE DE FALLOT

Pr RABEARIVONY Nirina

Introduction

- Définition:
 - cardiopathie congénitale cyanogène avec shunt D-G associant:
 - **sténose de la voie pulmonaire** (infundibulaire)
 - **ClV** (haute et large)
 - **dextroposition de l'AO** (AO à cheval sur SIV)
 - **HVD** (conséquence de la sténose pulm.)

Introduction



Introduction

- **Epidémiologie:**
 - 10 % des CP congénitales
 - la plus fréquente des CP congénitales cyanogènes viables
 - 75 % des CP cyanogènes observées après 2 ans
- ➔ « devant un enfant cyanosé, il faut en premier lieu penser à une Tt de Fallot jusqu'à ce que d'autres éléments entraînent vers le diagnostic d'une CP congén. cyanogène plus rare »

I) Diagnostic

I.1- Positif

I.11- Clinique

I.112- SF

- **cyanose:**
 - obligatoire
 - intensité variable d'un cas à l'autre et d'un moment à l'autre chez un même sujet
 - évidente au niveau des lèvres, ongles, langue, nez
 - accentuée / effort, cris, exposition au froid

I) Diagnostic

I.1- Positif

I.11- Clinique

I.112- SF

- **accroupissement (squatting)**
 - après un certain temps de marche ou de jeu
 - permet de ↘ le shunt D-G / ↗ des RP (plicature des gros vaisseaux des MI)
- **soif**
 - mécanisme de défense contre l'hémoconcentration (secondaire à la polyglobulie réactionnelle)

I) Diagnostic

I.1- Positif

I.11- Clinique

I.112- SF

- **dyspnée d'effort**
 - intensité variable
 - se traduit chez le nourrisson par des difficultés à la prise de biberons

I) Diagnostic

I.1- Positif

I.11- Clinique

I.112- SF

- **crises anoxiques**

- signes de gravité de la maladie
- dues au **spasme infundibulaire** →
diminution du Q° pulmonaire →
diminution brutale de la saturation
artérielle cérébrale en O₂
- se manifeste / **cyanose paroxystique**
perte de connaissance
crises convulsives
- survient spontanément ou à l'effort

I) Diagnostic

I.1- Positif

I.11- Clinique

I.113- SP

- inspection:

- retard staturo-pondéral

- **hippocratisme digital**

~ongles bombées, en « verre de montre »

~élargissement de la dernière phalange des doigts → « aspect en baguette de tambour »



I) Diagnostic

I.1- Positif

I.11- Clinique

I.113- SP

- palpation
 - frémissement systolique aux 3^è-4^è EIC gauche
- auscultation
 - Souffle systolique au 3^è EIC gauche
 - dû au passage du sang à travers la sténose pulm.
 - intensité très faible dans les formes sévères

I) Diagnostic

I.1- Positif

I.12- Radiographie

- pointe du cœur sus-diaphragmatique
- arc moyen creux
- hypovascularisation pulm. avec artères pulm. grèles



I) Diagnostic

I.1- Positif

I.12- ECG

- HVD : axe QRS déviée à droite ($> +110^\circ$)
onde R ample en V1
aspect isodiphasique RS de V2 à V6
- HAD (rare): P ample, pointue en D2

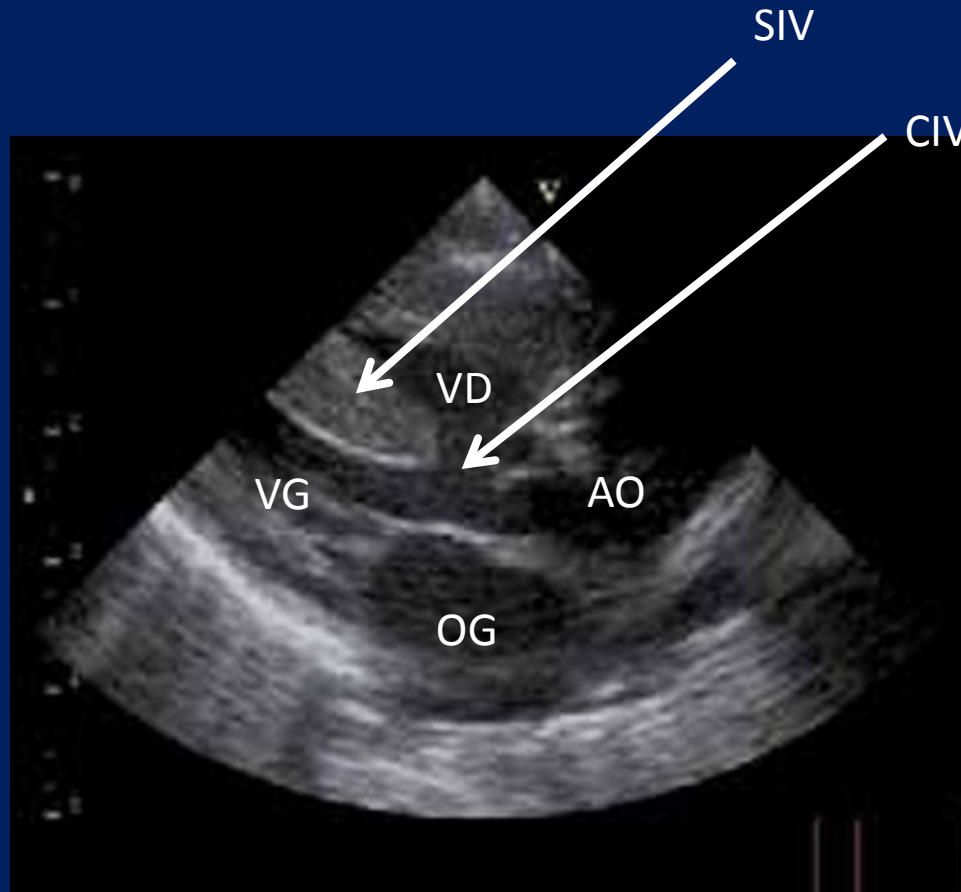
I.13- Echodoppler cardiaque

- met en évidence la CIV
- précise la dextroposition aortique

I) Diagnostic

I.1- Positif

I.13- Echodoppler cardiaque



I) Diagnostic

I.1- Différentiel

- Ventricule droit à double issu (VDDI)
- Ventricule unique
- transposition corrigée des gros vaisseaux + CIV
- transposition non corrigée des gros vaisseaux
- agénésie de la valve pulmonaire

II) Evolution

II.1- Spontanée

- défavorable à plus ou moins brève échéance selon l'importance de la sténose pulmonaire

II.2- Complications

II.21- Cardiovasculaires

- IC
- accidents thrombo-emboliques

II.22- Infectieuses

- abcès du cerveau
- endocardite bactérienne
- tuberculose pulmonaire